

Fonksiyonel Dispepsi

Rome IV temelli pozitif tanı, alarm bulgularının ayrımı ve alt tipe (PDS/EPS) yönelik dozlu tedavi ile izlem çerçevesi. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Rome IV

PDS / EPS

H. pylori

PPI · Prokinetik

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Fonksiyonel dispepsi (FD), Rome IV kriterlerine göre tanı öncesi en az 2 ay boyunca ayda ≥ 4 gün görülen ve dışkılama ile ilişkilendirilemeyen üst karın kaynaklı rahatsızlıktır: postprandiyal dolgunluk, erken doyma veya epigastrik ağrı/yanma. Uygun değerlendirme sonrası semptomlar başka bir tıbbi durumla tam olarak açıklanamamalıdır.

PDS — Postprandiyal Distres Sendromu (dolgunluk + erken doyma)

EPS — Epigastrik Ağrı Sendromu (ağrı/yanma)

Örtüşen alt tip mümkün

Öyküde sorgula

- Semptom paterni: öğünle ilişki (postprandiyal mi, açlıkta mı), lokalizasyon, gece uyandırma
- Sıklık/süre: ayda ≥ 4 gün, ≥ 2 ay eşiği ve okul devamsızlığı/yaşam kalitesi etkisi
- Tetikleyiciler: yağlı-baharatlı-kafeinli/gazlı gıda, atlanan öğün, hızlı yeme
- İlaç öyküsü: NSAİİ, kortikosteroid; reflü/eozinofilik özofajit örtüşmesi
- Psikososyal: anksiyete, depresyon, somatizasyon, aile stresörleri, uyku
- Aile öyküsü: IBD, çölyak, peptik ülser, H. pylori; alarm bulgularının aktif taranması

Muayenede değerlendir

- Büyüme: boy-kilo persentilleri ve boy hızı (doğrusal büyümede duraklama alarmdır)
- Karın: epigastrik hassasiyet tipik; kitle, organomegali, lokalize/rebound patolojiktir
- Perianal/rektal: fissür, fistül, gizli kan (IBD lehine ipuçları)
- Ekstraintestinal: solukluk, artrit, aftöz lezyon, cilt bulguları, puberte evresi
- Genel: ateş, dehidratasyon, beslenme durumu ve tartılı takip zemini
- Amaç: organik hastalığı dışlamak değil, pozitif FD tanısını desteklemek

Alarm bulgusu yoksa ve büyüme normalse FD, dışlama tanısı değil **pozitif klinik tanı** olarak konulmalıdır; kapsamlı invaziv tetkik rutin olarak gerekmez.

FD tek bir bozukluk değil, üst üste binen patofizyolojik yolların oluşturduğu bir bozulmuş beyin-bağırsak etkileşimidir. Baskın mekanizmayı öngörmek alt tip (PDS/EPS) seçimi ve tedavi hedefini yönlendirir.

Gastrik akomodasyon bozukluğu

- Fundusun öğüne yeterli gevşeyememesi
- Erken doyma ve postprandiyal dolgunluk (PDS)
- Hedef: fundik gevşeme (buspiron, siproheptadin)

Gecikmiş gastrik boşalma

- Antral hipomotilite, gastroparetik örtüşme
- Dolgunluk, bulantı, doyma hissi
- Hedef: prokinetik tedavi

Visseral hipersensitivite

- Gerilme/asit uyarısına artmış duyu
- Epigastrik ağrı/yanma baskın (EPS)
- Hedef: nöromodülatör, asit baskılama

Duodenal düşük dereceli inflamasyon

- Duodenal eozinofili ve mukozal geçirgenlik artışı
- Erken doyma ile ilişkili biyolojik belirteç
- Biyopside eozinofil değerlendirmesi anlamlı

Beyin-bağırsak eksen / psikososyal

- Anksiyete, somatizasyon, santral duyarlılaşma
- Semptom şiddeti ve süreklilik ile korelasyon
- Hedef: BDT, hipnoterapi, TCA

Enfeksiyon sonrası / mikrobiyota

- Postenfeksiyöz FD, disbiyoz
- H. pylori gastriti bir alt grupta katkıda bulunabilir
- H. pylori pozitifse eradikasyon değerlendirilir

03 Karar akışı

Klinik değerlendirme sonrası ilk çatal alarm bulgusudur; ikinci çatal Rome IV uyumu ve non-invaziv tarama sonuçlarıdır.

BAŞLANGIÇ

Kronik/tekrarlayan dispepsi

≥4 gün/ay ve ≥2 ay: epigastrik ağrı/yanma, postprandiyaal dolgunluk veya erken doyma.

ADIM 1

Öykü + muayene + büyüme

Beslenme, ilaç (NSAİİ), psikososyal ve aile öyküsü; persentil ve boy hızı, karın ve perianal muayene.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı, büyüme duraklaması, GİS kanama, disfaji, gece uyandıran ağrı, IBD/çölyak aile öyküsü.

EVET → Organik hastalığı dışla

HAYIR → Non-invaziv değerlendirme

HEDEFLİ TETKİK

Üst GİS endoskopi + biyopsi

Özofagus/mide/duodenum biyopsileri (H. pylori, eozinofili, çölyak); bulguya göre görüntüleme ve konsültasyon.

BASAMAKLI TARAMA

Sınırlı ilk-basamak test

Tam kan, CRP/sedim, çölyak serolojisi, KCFT, gaita kalprotektin; tümü normalse organik olasılık düşüktür.

KARAR 2

Rome IV karşılandı ve tarama normal mi?

Semptomlar başka bir durumla açıklanamıyor.

EVET → Pozitif tanı

HAYIR → Yeniden değerlendir

TANI

Fonksiyonel dispepsi (PDS/EPs)

Biyopsikososyal açıklama ve güvence; alt tipe göre PPI veya prokinetik başla, 4 haftalık izlem planla.

İLERİ TETKİK

Endoskopi / hedefli inceleme

Tarama pozitif veya dirençli seyir: endoskopi, gerekirse gastrik boşalma çalışması ve ilgili değerlendirme.

Alarm bulgusu yoksa tetkik kademeli ve sınırlı tutulur; endoskopi seçilmiş (alarm veya dirençli) olgulara ayrılır.

Alarm bulgusuz kronik dispepside kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Kan	Tam kan sayımı, CRP/ESR, KCFT, amilaz/lipaz, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), TSH, üre/kreatinin	Anemi, inflamasyon, hepatik/pankreatik hastalık ve çölyak taraması
Basamak 2 · Gaita	Fekal kalprotektin, gaita gizli kan, Giardia antijeni / parazit incelemesi	IBD ve enfeksiyöz nedenlerin ayrımı; kalprotektin yüksekse endoskopiye yönlendirir
Basamak 3 · Görüntüleme	Batın ultrasonografisi	Safra kesesi, pankreas, böbrek ve kitle değerlendirmesi; sağ üst/alt kadran ağrısında öncelikli
Basamak 4 · Endoskopi	Üst GİS endoskopi + çoklu biyopsi (özofagus, mide, duodenum)	Alarm bulgusu veya tedaviye dirençli olgu; H. pylori (histoloji + hızlı üreaz), eozinofilik özofajit/gastrit, çölyak, peptik ülser
Seçili · Motilite	Gastrik boşalma sintigrafisi	Dirençli PDS/gastroparetik örtüşme şüphesinde; rutin değil

H. pylori: ESPGHAN/NASPGHAN, fonksiyonel karın ağrısı/dispepside “**test-ve-tedavi**” stratejisini önermez. Non-invaziv testlerle (üre nefes testi, gaita antijeni) tanı amaçlı tarama yapılmamalıdır. H. pylori tanısı yalnızca endoskopik biyopsi temelli (pozitif histopatoloji + pozitif hızlı üreaz veya pozitif kültür) konur.

Aşağıdakilerden herhangi biri fonksiyonel tanıyı sorguladır ve hedefli tetkik ile (çoğunlukla endoskopi) organik hastalık dışlamasını gerektirir.

• İstemsiz kilo kaybı

• Doğrusal büyümede duraklama / boy hızında yavaşlama

• GİS kanama: hematemez, melena, hematokezya

• İnatçı veya safralı kusma

• Kronik şiddetli ishal

• Disfaji / odinofaji

• Gece uyandıran ağrı

• Umbilikustan uzak, lokalize veya persistan ağrı

• Açıklanamayan ateş

• Artrit / perianal (perirektal) hastalık

• Gecikmiş puberte, hepatosplenomegali

• IBD, çölyak veya peptik ülser aile öyküsü

Temel taş biyopsikososyal eğitim ve güvencedir; farmakoterapi alt tipe göre seçilir ve 4 haftalık deneme sonrası yanıt değerlendirilir. EPS'de asit baskılama, PDS'de prokinetik/fundik akomodasyon ajanı önceliklidir.

Fonksiyonel dispepside basamaklı ve dozlu tedavi

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Non-farmakolojik (tüm hastalar)	—
PPI · Omeprazol (EPS)	1–2 mg/kg/gün, sabah aç, tek doz (maks 40 mg/gün)
PPI · Esomeprazol (alternatif)	10 mg/gün (<20 kg); 20 mg/gün (≥20 kg) (maks 20 mg/gün)
H2RA · Famotidin	0,5 mg/kg/doz, günde 2 kez (maks 40 mg/doz)
Prokinetik · Domperidon (PDS)	0,25 mg/kg/doz, günde 3 kez öğün öncesi (maks 10 mg/doz, 30 m)
Siproheptadin (PDS)	0,25–0,5 mg/kg/gün, 2–3 doz (maks ~0,5 mg/kg/gün; küçük çocuk)
Amitriptilin (dirençli)	10 mg gece ile başla; 0,2–0,5 mg/kg (maks ~25–50 mg gece)

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Buspiron (akomodasyon)	Öğün öncesi düşük doz, titre (maks ~30 mg/gün, bölünmüş)
Nane yağı (enterik kaplı)	Yaşa/kiloya göre standardize kapsül

Yaklaşım: Tek ajanla 4 hafta dene; yanıt yoksa alt tipi yeniden gözden geçir ve mekanizmaya göre değiştir (ör. EPS'de PPI → nöromodülatör; PDS'de prokinetik → akomodasyon ajanı). BDT ve gut yönelimli hipnoterapi kanıta dayalı ek seçeneklerdir.

H. pylori endoskopik biyopside saptanırsa: eradikasyon (duyarlılığa göre, 14 gün)

İLAÇ	DOZ	NOT
PPI (omeprazol)	1–2 mg/kg/gün, 2 doz (maks 20 mg/doz)	Rejimin omurgası
Amoksisilin	50 mg/kg/gün, 2 doz (maks 2 g/gün)	Alerji yoksa tercih
Klaritromisin	20 mg/kg/gün, 2 doz (maks 1 g/gün)	Yalnızca duyarlıysa; direnç yaygınsa kaçın
Metronidazol	20 mg/kg/gün, 2 doz (maks 1 g/gün)	Klaritromisin dirençli/bilinmiyorsa alternatif
Bizmutlu dörtlü	Yüksek dirençte, ağırlığa göre	Duyarlılık test edilemiyor veya yüksek direnç bölgesinde

Eradikasyon rejimi mümkün olduğunca **antibiyotik duyarlılık testine** göre seçilmeli, süre 14 gün olmalı ve tedavi tamamlandıktan ≥4 hafta sonra non-invaziv testle (üre nefes testi veya gaita antijeni) başarı doğrulanmalıdır.

FD kronik-dalgalanan bir seyir gösterir; hedef semptom kontrolü, işlevsellik ve gereksiz tetkikin önlenmesidir.

İzlem

- Pozitif tanıyı güvence ile pekiştir; tekrarlayan invaziv tetkikten kaçın
- Farmakolojik denemeyi 4 haftada değerlendir, yanıt varsa 8 haftaya tamamla ve kademeli kes
- Semptom günlüğü ve tetikleyici (kafein, gazlı, yağlı, atlanan öğün) takibi
- Büyüme eğrisini her vizitte izle; yeni alarm bulgusunda yeniden değerlendir
- Uzun süreli PPI kullanımından kaçın; yanıt alındıysa kesme planı yap

Dirençli olguda

- Alt tip ve baskın mekanizmayı yeniden gözden geçir
- Komorbiditeleri ele al: anksiyete/depresyon, migren, otonom disfonksiyon, uyku
- Nöromodülatör (amitriptilin) veya fundik akomodasyon ajanı (buspiron) ekle
- Psikolojik tedaviye yönlendir: BDT, gut yönelimli hipnoterapi
- Okul devamsızlığı ve aile beklentilerini yönet; multidisipliner destek

Etkin güvence ve eğitim, sık remisyon-alevlenme döngüsünde en tutarlı sonucu verir; farmakoterapi tek başına değil, biyopsikososyal plan içinde konumlandırılmalıdır.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Jones NL, Koletzko S, Goodman K, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(6):991-1003.
3. Thapar N, Benninga MA, Crowell MD, et al. Paediatric functional abdominal pain disorders. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:89.
4. Rexwinkel R, Vlieger AM, Saps M, et al. A therapeutic guide on paediatric irritable bowel syndrome and functional abdominal pain-not otherwise specified. Eur J Pediatr. 2021;180(9):2839-2850.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel duyarlılık verilerinin yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.